

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БЕЗ МИФОВ И ПАНИКИ»

Руководство к действию: как спасти жизнь до приезда врачей и не стать жертвой самому.

Разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом РФ.
- Постановлением Правительства РФ № 2464.
- Актуальными приказами Минздрава РФ.

Введение. Почему вы должны это прочитать?

Забудьте всё, что вы видели в кино. В реальной жизни, когда коллега падает без сознания, гость начинает задыхаться, а из за разбитого стекла хлещет кровь — время замирает, а в голове наступает звенящая пустота. Главный враг в экстренной ситуации — не травма. Главный враг — это паника и страх сделать хуже.

Люди боятся оказывать помощь. Боятся навредить, боятся юридической ответственности, боятся подойти к пострадавшему. Этот страх стоит людям жизни, ведь при остановке сердца мозг погибает всего за 4–5 минут. Скорая помощь физически не успеет приехать за это время, даже если машина стоит в соседнем квартале.

Ваша задача — не быть врачом. Вы не будете ставить диагнозы, назначать таблетки или проводить операции. Ваша цель как очевидца — стать тем самым спасательным мостом, который удержит человека в живых до приезда профессионалов.

Этот курс создан не для галочки. Мы разберем реальные рабочие ситуации, разрушим опасные мифы (почему нельзя хлопать по спине подавившегося человека и зачем зеркальце при проверке дыхания) и дадим вам четкие, железобетонные алгоритмы. Алгоритмы, которые работают на уровне рефлексов.

Программа курса:

- **Тема 1. Фундамент спасения:** Юридическая защита спасателя, оценка собственной безопасности и правильный вызов экстренных служб.
- **Тема 2. Базовая реанимация (СЛР) и бессознательные состояния:** Как понять, что человек на грани, и как завести ему остановившееся сердце.
- **Тема 3. Кровотечения и раны:** Виды кровотечений, подручные средства и правильная работа с аптечкой.
- **Тема 4. Агрессивная среда (травмы, ток, температура, яды):** Алгоритмы спасения при электротравмах, химических ожогах, отравлениях и обморожениях.
- **Тема 5. Инородное тело в дыхательных путях:** Прием Геймлиха для взрослых и детей — как за секунду вернуть человеку дыхание.

Тема 1. Фундамент спасения: Право, безопасность и алгоритм вызова

Практический кейс: «Страх, начальник и искрящийся кабель»

Представьте типичную рабочую смену. Раннее утро. Сотрудник идет по коридору или обходит территорию и видит, что на полу лежит человек в спецовке подрядчика. Рядом искрит перебитый кабель строительного пылесоса. Человек не шевелится.

В этот момент в голове очевидца проносится ураган мыслей: *"Я не врач, я только наврежу! А вдруг он пьяный и сейчас набросится на меня? Надо срочно позвонить директору, пусть руководство решает, что делать! А если я начну его трогать, он умрет, и меня потом посадят!"*

Этот внутренний монолог — классическая **ментальная ловушка**. Именно из-за нее теряются драгоценные секунды, отделяющие жизнь от смерти. Давайте разберем эти страхи и разрушим мифы, опираясь на физиологию и закон.

Страх 1: «Я не врач, меня засудят, если я сделаю что-то не так»

Люди панически боятся оказывать помощь, потому что путают ее с профессиональной медициной.

В законе есть четкое разделение. Первая помощь оказывается пострадавшим строго до оказания медицинской помощи. Вы не назначаете таблетки, не делаете уколы и не проводите хирургические операции. Ваша задача — выполнить простейшие действия, которые не дадут организму погибнуть до приезда профессионалов.

Кто имеет право это делать? Закон говорит однозначно: оказывать первую помощь вправе любой человек. Для этого не нужен диплом хирурга. За правильные действия по спасению жизни не наказывают — закон находится на стороне спасателя (в Уголовном кодексе РФ это квалифицируется как действие в состоянии крайней необходимости).

Страх 2: «А вдруг он против? А вдруг он буйный?»

Юридический парадокс: можно ли прикасаться к человеку и спасти его без его разрешения?

Закон отвечает предельно логично: оказывать помощь без спроса можно, но только если пострадавший находится без сознания и не может

вам ответить. В этом случае работает юридическое правило «подразумеваемого согласия» — считается, что любой человек, чей мозг отключился, хотел бы остаться в живых. Если же человек в сознании, вы обязаны спросить разрешения.

А что делать, если пострадавший очнулся, не понимает, где находится, проявляет агрессию и отталкивает вас? У профессиональных спасателей есть железное правило: **ваша жизнь всегда в приоритете**. Если человек агрессивен, правильнее всего не оказывать помощь, если это опасно, и обязательно сообщить о таком человеке в полицию. Вы не обязаны рисковать собой и вступать в драку с человеком в состоянии шока.

● **Страх 3: «Надо срочно бежать спасать!»**

Возвращаемся к нашему кейсу. Сотрудник видит лежащего коллегу и искрящийся кабель. Если инстинкт заставит его немедленно броситься к телу, чтобы проверить пульс, его тоже ударит током. Приехавшая скорая найдет уже двух пострадавших вместо одного.

Самое главное, абсолютное правило любой экстремальной ситуации: прежде чем оказать первую помощь пострадавшему, необходимо осмотреть место происшествия. Вы обязаны убедиться в собственной безопасности. Не навис ли сверху сорвавшийся груз? Не скопился ли в помещении ядовитый газ? Нет ли угрозы обрушения? Оцените обстановку — мертвый спасатель никому не поможет.

● **Страх 4: «Надо сначала доложить начальству, пусть они решают»**

Это чисто корпоративный рефлекс — страх нарушить субординацию. Но при клинической смерти счет идет на минуты. Пока вы звоните руководителю, пока тот берет трубку и вникает в ситуацию, человек безвозвратно угасает.

Если вы не можете дозвониться до руководства, чтобы сообщить о происшествии, вы не только можете, но и должны немедленно приступить к спасению. Чем быстрее вы начнете оказывать помощь, тем выше шансы на спасение. Жизнь человека неизмеримо важнее рабочих регламентов. Доложите по инстанции сразу после того, как устраните непосредственную угрозу для жизни.

Искусство вызова помощи: Кому звонить и что говорить?

Когда вы поняли, что вам ничего не угрожает, необходимо вызвать помощь. Номер 112 должен быть в быстром наборе. В состоянии паники люди часто путаются в инстанциях. Важно четко понимать, что к экстренным службам, способным примчаться с мигалками для спасения людей, относятся Скорая помощь и Полиция. Различные службы ЖКХ (например, коммунальщики) экстренными не являются.

Как говорить с диспетчером?

Типичная фатальная ошибка: *"Алё! Тут мужчине на стройке плохо! Он упал! Приезжайте быстрее!"* — и бросить трубку.

Куда приехать? Кому мужчине? Диспетчер скорой помощи не видит вас через экран.

Информацию нужно выдавать четко, как военный доклад. Правильный алгоритм сообщения диспетчеру включает в себя: что произошло, точный адрес, данные пострадавшего (или пострадавших) и контакты для связи.

Два самых критичных пункта, которые вы обязаны назвать диспетчеру без запинки — это точный адрес места происшествия и количество пострадавших. Почему так важно назвать количество? Потому что если пострадавших трое, а приедет одна бригада СМП (скорой медицинской помощи), врачам придется прямо на месте делать страшный выбор — кого спасти первым, а кому дать умереть.

Никогда не ставьте диагнозы по телефону, вы не врач. Просто опишите, что видите («лежит без сознания», «сильно течет кровь из ноги»). И **никогда не кладите трубку первым!** Диспетчер может координировать ваши действия и давать инструкции по оказанию помощи прямо по телефону, пока бригада находится в пути.

Главные выводы модуля (шпаргалка для мозга)

1. **Твоя безопасность — это шаг №1.** Прежде чем бежать на помощь, остановись и осмотри место происшествия.
2. **Спасать может каждый.** Первая помощь — это не медицина, это удержание человека в живых. Ее вправе оказывать любой человек.
3. **Согласие по умолчанию.** Человек без сознания автоматически «согласен» на помощь. Если он в сознании — спроси. Если буйный — отойди и звони в полицию.
4. **Действуй, а не жди приказа.** Не жди ответа начальника — начинай помощь немедленно.
5. **Вызывай правильно.** Скорая помощь приедет быстро, если дать ей точные координаты. Назови точный адрес, что случилось, количество пострадавших и оставь свой контактный телефон.

Тема 2. Базовая реанимация (СЛР) и бессознательные состояния

Практический кейс: «Зеркальце, пощечины и потерянное время»

Представьте жаркий летний день. На территории комплекса (например, у бассейна или на летней террасе) человек внезапно бледнеет и падает на плитку. Вокруг мгновенно собирается толпа.

Начинается классический хаос: один с силой бьет пострадавшего по щекам, пытаясь привести в чувство. Другой кричит: «Несите зеркальце, проверим, дышит ли он!». Третий пытается нащупать пульс на запястье, но руки дрожат от адреналина.

В этой суете уходят самые дорогие минуты. Мозг человека без кислорода живет не больше 4-5 минут. Давайте остановим эту панику и разберем, как действовать холодно, четко и по науке.

Шаг 1: Как понять, что человек без сознания?

Многие думают: раз не шевелится — значит, без сознания. Но человек может просто глубоко спать или находиться в ступоре. Главный признак того, что пострадавший без сознания — он не реагирует на голос. **Что делать?** Громко окликните его («Вам нужна помощь?») и аккуратно, но ощутимо встряхните за плечи. Если реакции нет — мозг отключен. Мы переходим в экстренный режим.

Шаг 2: Дышит или нет? (Смертельный миф о зеркальце)

Кинематограф научил нас красивому, но смертельно опасному приему: поднести ко рту зеркальце или пушинку. В реальной жизни на вопрос, стоит ли проверять дыхание с помощью зеркальца или перышка, ответ категоричный: нет, так как есть риск неправильно оценить состояние пострадавшего. Зеркало может запотеть от ваших собственных рук, а перышко сдует ветер.

Как правильно проверить признаки жизни у пострадавшего?

Необходимо проверить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания. Но прежде, чем это сделать, нужно выполнить критически важное действие. У человека без сознания расслабляются все мышцы, и корень языка перекрывает дыхательные пути, как пробка. Если вы просто наклонитесь к нему, вы не услышите дыхания.

Поэтому правильная последовательность действий при обнаружении пострадавшего без сознания такова:

1. Сначала нужно восстановить проходимость дыхательных путей запрокидыванием головы с подъемом подбородка.
2. Только после этого наклониться над его лицом и попытаться услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение грудной клетки в течении 10 секунд.
3. Если дыхание есть — немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.
4. Затем придать пострадавшему устойчивое боковое положение (чтобы он не захлебнулся рвотными массами).

Этот прием проверки дыхания называется «Слышу, ощущаю, вижу». Это не три разных действия, а один комплекс: вы слушаете, есть ли дыхание (слышу), пробуете понять, чувствуете ли вы дыхание на своей щеке (ощущаю), и смотрите, опускается и поднимается ли грудная клетка или живот (вижу).

Если же по какой-то причине (расширенный протокол) вы проверяете пульс, то делать это на руке бессмысленно — при падении давления он там пропадает. Правильно будет проверить пульс на сонной артерии и наличие дыхания.

Шаг 3: Обморок, Кома или Клиническая смерть? Разбираемся в состояниях

1. Простой обморок (мозгу просто не хватило крови) Если человек упал в обморок, не нужно бить его по лицу, лить на него ведра воды или давать нюхать нашатырь (он может вызвать спазм дыхания). Правильный алгоритм действий при обмороке: положите пострадавшего на спину, поднимите ноги выше уровня головы (чтобы кровь по законам физики прилила обратно к мозгу), откройте окна в помещении для притока кислорода. После этого обязательно вызовите скорую и контролируйте пульс пострадавшего.

2. Кома (глубокое поражение мозга)

Грань между обмороком и комой — это время. В каких случаях стоит предположить наступление комы?

- Если пострадавший потерял сознание в вашем присутствии и с этого момента прошло более 4 минут.
- Действует и универсальное правило безопасности: если вы не были очевидцем несчастного случая и не знаете, сколько прошло времени — всегда предполагайте кому и немедленно вызывайте медиков.

3. Остановка сердца (Клиническая смерть)

Если во время оказания помощи пострадавший внезапно побледнел и перестал реагировать на окружающее, это признак остановки кровообращения. Универсальная последовательность действий (алгоритм СЛР) выстроена предельно логично:

1. Проверьте признаки сознания (задать вопрос громким голосом и встряхнуть пострадавшего за плечи).
2. Откройте дыхательные пути.
3. Проверьте признаки дыхания.
4. Вызовите скорую медицинскую помощь.
5. Начнете компрессию грудной клетки.

Шаг 4: До какого момента нужно «качать» сердце?

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — это тяжелый физический труд. Вы своими руками гоняете кровь по чужому организму. До какого момента нужно откачивать пострадавшего? Закон и физиология дают три четких ответа:

- Пока не приедет скорая (и профессионалы не перехватят инициативу).
- Пока не появится пульс (человек ожил, задышал сам).
- Пока есть собственные силы (если вы падаете в обморок от истощения, вы никого не спасете).

Важное примечание о трупных пятнах: Реанимацию не проводят, если есть явные признаки биологической смерти (например, трупные пятна). Но будьте предельно внимательны! Трупные пятна не появляются в тех случаях, когда пострадавший лежит на морозе, утонул или потерял много крови. В этих ситуациях человек может выглядеть безжизненно бледным, но его еще можно спасти. Качайте!

Главные выводы модуля (шпаргалка для мозга)

1. **Проверка сознания:** Нет реакции на голос и встряхивание — мозг отключен.
2. **Открой путь воздуху:** Прежде чем слушать дыхание, всегда запрокидывай голову — иначе язык перекроет горло.
3. **Правило 10 секунд:** Наклонись к лицу. Слышу ухом, ощущаю щекой, вижу глазами (движение груди). Пульс ищи только на шее.
4. **Обморок — это ноги вверх:** При обмороке просто поднимите ноги выше головы и дайте приток свежего воздуха. Если без сознания дольше 4 минут (или время неизвестно) — это кома.
5. **Алгоритм спасения жизни:** Сознание → Дыхательные пути → Дыхание → Звонок в 112 → Компрессия грудной клетки. Качаем до приезда врачей, до появления пульса или пока есть силы.

Тема 3. Кровотечения и раны.

Практический кейс: «Осколок, зеленка и паника»

Представьте: на кухне ресторана или в ремонтном цехе разбивается витрина (или срывается инструмент). Работник получает глубокий порез предплечья, в котором застревает крупный осколок стекла. Кровь начинает бить прерывистым фонтаном, заливая пол.

Коллеги в ужасе бросаются на помощь. Один кричит: «Срочно вытащите стекло, чтобы не мешало!». Другой бежит за аптечкой и судорожно ищет перекись или йод, чтобы залить рану, а третий пытается перетянуть руку шнурком где-то в районе локтя.

В этом коротком сценарии коллеги совершили сразу несколько смертельно опасных ошибок. Давайте разберем физиологию травмы и выясним, как правильно останавливать кровь, чтобы человек дождался приезда врачей.

Шаг 1: Разбираемся в терминах

В состоянии стресса люди называют «раной» любое повреждение, на котором выступила кровь. Но для правильного оказания помощи нужно четко понимать терминологию.

- **Царапина** — это поверхностное повреждение, нанесённое острым предметом в виде тонкой линии.
- **Ссадина** — это неглубокие раны с повреждением только поверхностных слоёв кожи или слизистой оболочки, нанесённые плоским предметом на большом протяжении (например, асфальтная болезнь при падении).
- А вот **рана** — это глубокое нарушение целостности кожи, слизистых оболочек с повреждением различных тканей и органов, вызванное механическим воздействием.
- Само по себе **кровотечение** — это потеря крови, возникающая вследствие повреждения кровеносных сосудов.

Две самые главные и смертельные опасности, которые связаны с любым сильным кровотечением — это потеря крови (человек умирает от падения давления в системе) и занесение инфекции. Именно поэтому заливать в

глубокую рану йод бесполезно и опасно (вы сожжете ткани), наша главная задача — остановить утечку и закрыть вход для бактерий.

● Шаг 2: Цветовая дифференциация. Какая это кровь?

Методы спасения кардинально отличаются в зависимости от того, какой сосуд поврежден. Вы обязаны уметь определять это на глаз:

- **Капиллярное кровотечение:** слабое истечение крови, повреждения кожи неглубокие (ссадины, царапины, мелкие порезы). Это не угрожает жизни, достаточно просто прижать чистую ткань.
- **Венозное кровотечение:** кровь тёмно вишнёвого цвета, вытекает медленной струёй. Давление в венах низкое, поэтому фонтана не будет. Такую утечку отлично останавливает давящая повязка прямо на место ранения.
- **Артериальное кровотечение:** самое опасное. Это ярко алая кровь, вытекает сильной струёй (часто пульсирующей в такт ударам сердца). Человек может истечь кровью за несколько минут. Здесь счет идет на секунды, и требуется жесткое прижатие артерии.
- **Внутреннее кровотечение:** самый коварный враг спасателя. Крови не видно вообще! Удар пришелся в живот или грудь, сосуд лопнул внутри, и кровь выливается в полости тела. Главные признаки, по которым вы должны распознать катастрофу: слабость, бледная кожа, холодный пот, частый слабый пульс, учащенное дыхание. При таких симптомах нужно немедленно вызывать скорую — спасти человека могут только хирурги на операционном столе.

● Шаг 3: Как остановить фонтан? (Точки прижатия)

Вернемся к нашему кейсу. У пострадавшего артериальное кровотечение (алая струя). Коллега пытается перетянуть локоть, но кровь не останавливается. Почему? Кровеносные магистрали спрятаны глубоко в мышцах. Чтобы перекрыть трубу с высоким давлением, ее нужно прижать к твердой поверхности — к кости. Передавить артерию при артериальном кровотечении нужно там, где она находится ближе всего к костям, образуя своеобразные природные «вентили».

Где можно передавить артерию эффективно? Запомните три главные спасательные зоны:

- В области шеи, около сонной артерии.
- В подмышечной области.
- В области паха.

Только сильное давление кулаком или пальцами в этих местах перекроет кровоток и даст вам время подготовить давящую повязку или жгут.

Шаг 4: Эффект пробки (Почему нельзя трогать стекло)

Второй коллега в нашем кейсе пытался вытащить торчащий из руки осколок стекла. Это фатальная ошибка. Извлекать инородное тело из раны нельзя! Представьте себе пробитую бочку с водой, в которой застрял лом. Пока лом торчит в отверстии, он сдерживает поток. Как только вы его вытащите, вода хлынет с максимальной силой. Осколок стекла, кусок арматуры или нож в ране работают как пробка, сдерживающая массивное кровотечение. Кроме того, при попытке достать предмет, вы можете разрезать сосуды и нервы, которые до этого оставались целыми. Инородное тело нужно аккуратно зафиксировать бинтами по бокам и оставить его извлечение хирургам.

Шаг 5: Аптечка без чудес

Люди часто ищут в аптечке волшебные спреи, кровоостанавливающие порошки или инновационные пластыри. Но закон и логика суровы: в аптечку первой помощи обязательно должны входить изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. На вопрос новичков, нужно ли включать в состав аптечки марлевый бинт, ответ бескомпромиссный — нужно. Ни один пластырь в мире не создаст давления, достаточного для остановки серьезного кровотечения. Бинт — это фундамент спасения. Нет бинта — вам нечем давить на рану.

Главные выводы модуля (шпаргалка для мозга)

1. **Цвет и струя:** Темная кровь и медленная струя — вена (хватит давящей повязки). Алая кровь и сильная струя — артерия (нужно жесткое прижатие и жгут).
2. **Внутренняя угроза:** Крови нет, но человек бледнеет, покрывается холодным потом и часто дышит — это внутреннее кровотечение. Срочно нужна скорая!
3. **Ищи природные вентили:** Не дави там, где мягко. Артерии нужно прижимать к кости в паху, подмышке или на шее.
4. **Не лезь в рану:** Торчащий предмет (стекло, металл) — это пробка, сдерживающая смерть. Вытаскивать инородные тела категорически нельзя.
5. **Бинт всему голова:** В любой аптечке всегда должны быть бинты и перевязочные пакеты. Это ваш главный инструмент.

Тема 4. Агрессивная среда: Травмы, электричество, температуры и химия

Практический кейс: «Цепная реакция на производстве»

Представьте сложную, но вполне реальную ситуацию на территории крупного объекта. Техник проводит работы на грузоподъемной вышке (или лесах). Происходит пробой изоляции, машина оказывается под напряжением. Техник получает удар током и падает на землю с высоты. От резкого звука и вспышки находящаяся рядом уборщица пугается, роняет емкость с концентрированным моющим средством (щелочью), и едкие брызги летят ей прямо в лицо.

Начинается паника. Коллеги пытаются запрыгнуть на гудящую машину, чтобы выключить рубильник. Кто-то бежит к упавшему технику и сразу начинает дергать его за неестественно вывернутую сломанную ногу, чтобы «вправить» кость. А уборщице советуют просто поморгать или наложить на глаз повязку.

Каждое из этих действий — прямой путь к инвалидности или смерти. Давайте разберем этот хаос по частям и выстроим четкую систему спасения.

Шаг 1. Электричество — невидимый убийца

Первая угроза — это грузоподъемная машина, находящаяся под напряжением. Электричество не имеет ни запаха, ни цвета, оно убивает мгновенно. Если техника оказалась под напряжением, смертельно опасно играть в героя. Категорически нельзя спускаться с неё на землю, прикасаться к ней снаружи или пытаться подниматься на неё до снятия напряжения. Вы станете проводником. Единственное правильное действие для того, кто остался на технике — стоять на месте и ждать полного обесточивания линии.

Миф о «легком ударе»: Техник упал. Он в сознании, отряхивается и говорит: «Да нормально всё, просто трянуло и голова кружится, не надо скорую». Можно ли его отпустить домой? Категорически нет! Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния пострадавшего. Ток проходит через тело по пути наименьшего сопротивления, часто задевая сердце. Электротравма может вызвать фатальную аритмию и остановку сердца даже спустя несколько часов после удара. Скорая обязательна всегда!

Шаг 2. Травмы при падении. Правило «Сверху вниз»

Техник лежит на земле. Окружающие видят, что его нога сломана (торчит под странным углом), и инстинктивно бросаются к ней. Это «туннельное зрение» спасателя. Сломанная нога выглядит страшно, но она не убьет человека за минуту. А вот перелом шейных позвонков убьет.

Поэтому мировой стандарт травмотроа требует строгой очередности по степени критичности органов для выживания: от главного компьютера (мозга) к периферии. Запомните этот алгоритм:

1. Сначала осмотрите и ощупайте голову. Защита мозга — приоритет.
2. Затем осмотрите шею на наличие деформации, костных выступов и болезненных мест. Защита спинного мозга.
3. Далее осмотрите грудную клетку, без необходимости не переворачивайте пострадавшего, чтобы осмотреть спину. Достаточно аккуратно ощупать.
4. После этого осмотрите живот и область таза (здесь могут быть скрытые внутренние кровотечения).
5. И только в самом конце осмотрите руки и ноги, где деформация может быть одним из признаков перелома костей.

● Шаг 3. Химия и Яды.

Тем временем уборщица кричит от боли — химия попала на лицо. Чтобы правильно бороться с токсинами, нужно понимать пути проникновения токсичного вещества в организм. Логика здесь проста:

- Отравление газом всегда происходит через дыхательные пути.
- Пищевое отравление атакует через пищеварительный тракт.
- Отравление специфическим ядом (укусы животных, введение яда шприцем) — это проникновение в результате инъекции.
- А вот химическое отравление (кислоты, щелочи, растворители) поражает нас через кожу и слизистые оболочки.

Спасение глаз: Химия в глазу продолжает сжигать роговицу каждую секунду. Строгая последовательность оказания помощи при химическом ожоге глаз выглядит так:

1. Обеспечить безопасные условия оказания первой помощи.
2. Осторожно раздвинув веки пальцами, обильно промыть глаза чистой водой комнатной температуры от переносицы к периферии. Направление «от носа к виску» критически важно — если мыть наоборот, ядовитая вода стечет на переносицу и сожжет второй, здоровый глаз!
3. Вызвать СМП (скорую помощь).
4. Обязательно наложить повязку на оба глаза. Даже если пострадал один глаз, завязывать нужно два, потому что глазные яблоки двигаются синхронно. Если один глаз будет смотреть по сторонам, второй под повязкой тоже будет двигаться и травмироваться.
5. Сопровождать пострадавшего при перемещении (человек с завязанными глазами абсолютно беспомощен).

● Шаг 4. Экстремальные температуры (Жара и Холод)

Работы на объектах проходят круглый год. Температурные травмы — классика производственного травматизма.

Жара: Если сотрудник долго находился на солнце или в душном бойлерном помещении, важно правильно подобрать прием первой помощи в зависимости от симптома:

- Солнечные ожоги нужно не мазать сметаной, а просто охладить.
- Если началась сильная головная боль — необходимо приложить холод к голове.
- При потере сознания от теплового удара — повернуть на бок (чтобы не запал язык).

Холод: Зимой главная угроза — обморожение. Главная ошибка новичков — пытаться согреть побелевшую конечность снаружи. Растирать обмороженные части тела снегом, опускать в горячую воду или втирать кремы — категорически запрещено! Ткани промерзли, кровотока в них нет. Внешнее тепло (батарея или горячая вода) просто сварит мертвые клетки. Ткани должны согреваться медленно и изнутри, за счет восстанавливающегося кровотока самого организма. Поэтому правильная помощь — переместить пострадавшего в теплое помещение, дать теплое питье. Поврежденные места необходимо укрыть ватой, одеялом, одеждой или наложить повязку, желательно использовать шерстяной платок.

Для сильных обморожений создается специальная **теплоизолирующая повязка**, работающая по принципу термоса. Порядок слоев строгий:

1. Стерильный материал (ближе к телу, для защиты от инфекции).
2. Толстый слой ваты (создает воздушную подушку).
3. Воздухонепроницаемый материал, например полиэтилен или клеёнка (блокирует теплообмен со средой).
4. Шерстяная ткань — шарф, платок, одеяло (утепляет конструкцию сверху).

💡 **Главные выводы модуля (шпаргалка для мозга)**

1. **Ток не прощает ошибок.** Машина под напряжением — не подходи, не слезай, не трогай. Ударило током? Скорая нужна 100%, даже если человек чувствует себя нормально.
2. **Осмотр — сверху вниз.** Не кидайся к сломанной ноге. Проверь голову → шею → грудь/спину → живот → руки/ноги.
3. **Химия в глазах — вода от носа к уху.** Мой от переносицы к виску. Повязку накладывай строго на оба глаза, чтобы обездвижить их.
4. **Обморожение грей изнутри.** Не три снегом, не суй в кипяток! Укутай конечность в «термос» (бинт → вата → клеенка → шерсть) и напои человека горячим чаем.

Тема 5. Инородное тело в дыхательных путях: спасение за секунды

Практический кейс: «Ресторан, кусок мяса и медвежья услуга»

Представьте классическую ситуацию: корпоративный обед в столовой или ужин гостя в ресторане комплекса. Человек ест, оживленно разговаривает, смеется и вдруг резко замолкает. Он хватается руками за горло, глаза расширяются от ужаса, лицо стремительно краснеет, а затем начинает синеть. Он не может ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни откашляться. Произошло полное перекрытие дыхательных путей.

Что обычно делают окружающие? Кто-то с криком «Похлопай его!» подбегает и начинает изо всех сил лупить задыхающегося кулаком по спине, пока тот сидит прямо. Другой советует вызвать рвоту или лезет пальцами пострадавшему в рот.

Стоп! Эти народные методы — прямая дорога к трагедии. Давайте разберем физику процесса и научимся знаменитому приему, который спасает жизни за секунды.

Шаг 1. Физика удушья и опасные мифы

Если человек подавился и дыхательные пути полностью заблокированы, бить его по спине в вертикальном положении категорически нельзя! По законам гравитации и физики от удара по вертикальной трубе (трахее) застрявший кусок провалится только глубже, застрянет намертво, и спасти человека смогут только реаниматологи.

Также фатальной ошибкой являются попытки вызвать рвоту, надавив на корень языка, или наклонить пострадавшего и сильно ударить кулаком по спине. Кулаком вы можете сломать ребра или повредить позвоночник, а рвотные массы окончательно забьют дыхательные пути.

В основе правильной помощи лежит эффект пневматического поршня. В легких задыхающегося человека всегда остается резервный запас воздуха. Наша задача — резко сжать этот воздух, чтобы он вытолкнул инородное тело наружу, как пробку из бутылки шампанского.

Шаг 2. Спасение взрослого (Прием Геймлиха)

Действовать нужно мгновенно, мозг живет без кислорода считанные минуты. Правильный алгоритм для взрослого человека выглядит так:

1. **Сначала — гравитация.** Необходимо наклонить пострадавшего, ударить несколько раз ладонью по спине. Обратите внимание: бьем не кулаком, не ребром, а именно основанием открытой ладони. Наклон нужен для того, чтобы выбиваемый предмет падал изо рта вниз, на пол, а не обратно в горло.
2. **Эффект поршня (Прием Геймлиха).** Если удары не помогли, необходимо встать сзади него, обхватить руками на уровне нижних ребер, соединить руки и резко надавить на живот в направлении внутрь и вверх. Это резкое давление на диафрагму сжимает легкие, и остаточный воздух с силой выбивает кусок наружу.

● Шаг 3. Спасение ребенка (старше 1 года)

Дети — это не уменьшенные копии взрослых, их внутренние органы гораздо более хрупкие. Ребенок, бегающий с леденцом или мелкой игрушкой во рту, — это бомба замедленного действия.

Если у ребенка старше 1 года произошло полное нарушение проходимости дыхательных путей, алгоритм похож на взрослый, но требует строгой дозировки усилий. Запомните эту последовательность шаг за шагом:

1. **Правильная позиция:** Встать сбоку и немного сзади пострадавшего ребенка. Придерживая его одной рукой, другой наклонить его вперед. Ребенок должен быть надежно зафиксирован.
2. **Удары по спине:** Нанести 5 резких ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего ребенка, дозируя усилия. Не бейте со всей взрослой силы, соизмеряйте удар!
3. **Обязательный контроль:** Критически важно проверять после каждого удара, не удалось ли устранить нарушение проходимости. Если кусок вылетел после второго удара, продолжать бить не нужно.
4. **Брюшные толчки:** Если после 5 ударов инородное тело не удалено, то перейти к надавливаниям на живот над пупком в направлении внутрь и вверх, дозируя усилия. При необходимости повторить до 5 раз.
5. **Финал:** Даже если всё закончилось хорошо, расслабляться рано. Трахея могла быть травмирована. Когда вследствие надавливания инородное тело удалено контролировать состояние ребенка, вызвать скорую медицинскую помощь. Врачи обязаны осмотреть спасенного.

 Главные выводы модуля (шпаргалка для мозга)

1. **Не бей прямо сидящего!** Всегда наклоняй пострадавшего вперед перед ударом.
2. **Никаких кулаков.** Бьем только основанием ладони между лопаток.
3. **Принцип «поршня».** Если удары по спине не сработали, обхватываем сзади, сцепляем руки и давим на живот внутрь и резко вверх («крюком» под ребра).
4. **Правило 5 к 5 для детей.** Наклони → нанеси до 5 ударов по спине (дозируя силу) → проверяй после каждого удара → если не вышло, сделай до 5 толчков в живот → обязательно вызови скорую после спасения.